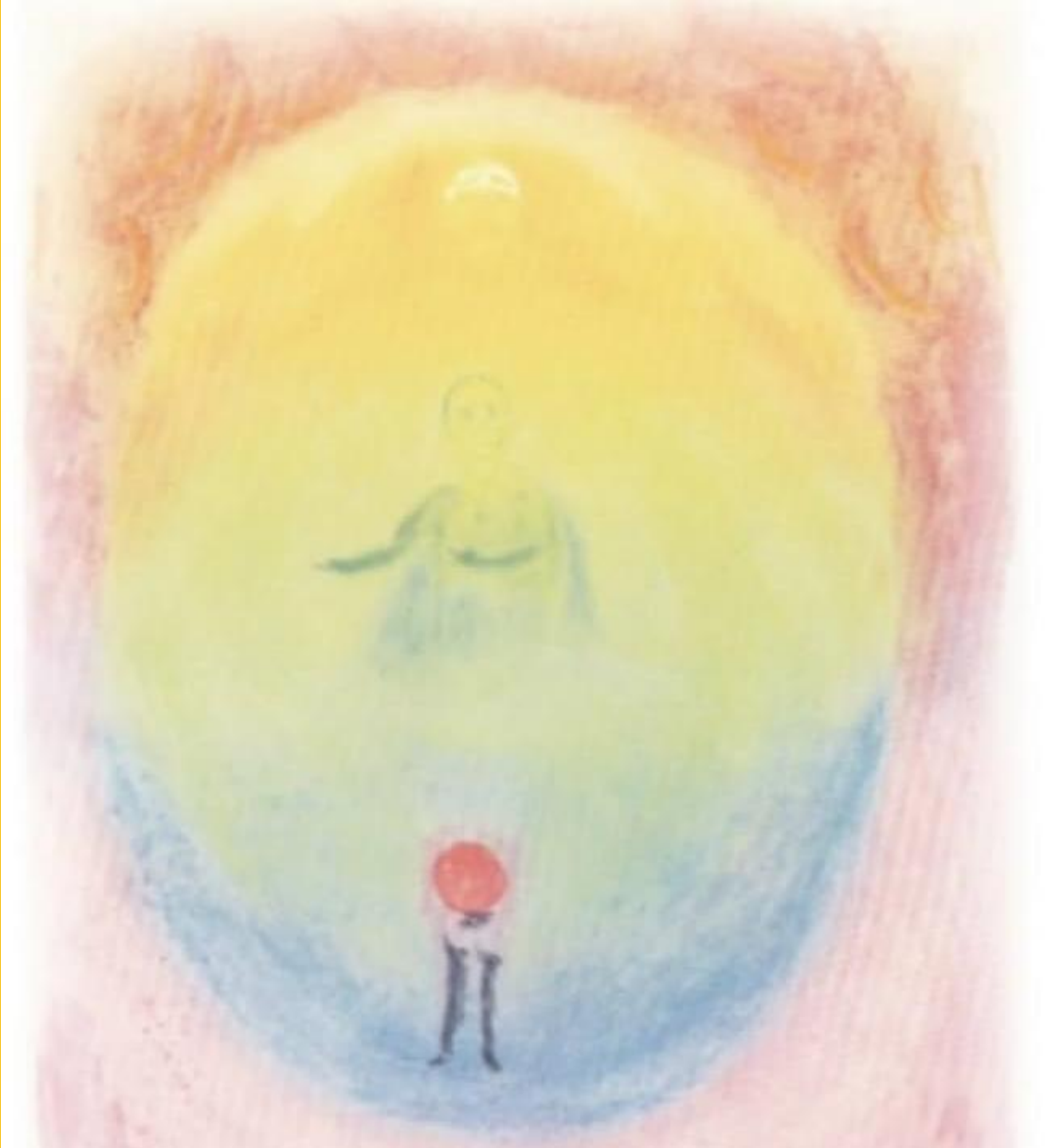


Системно-структурний підхід у реабілітації.

**Концепт холістично-салютогенетичного
підходу в реабілітації.**



Системний підхід

Людина розглядається як цілісна істота, у якій відбувається поєднання та взаємодія тілесного, душевного та духовного принципів існування матерії.

Структура



Згідно з структуралістською феноменологією Генріха Ромбаха (1923-2004), розум притаманний не тільки свідомості, а також і навколишньої дійсності.

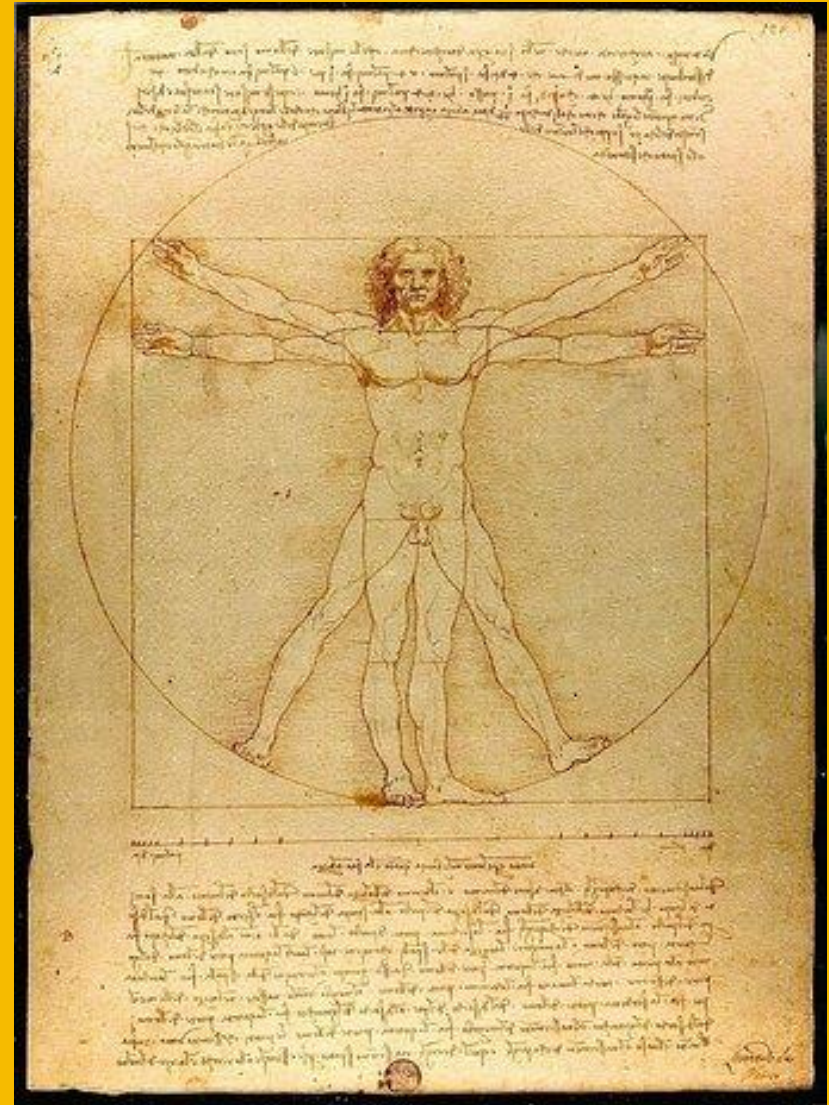
У основі реальності та свідомості лежать структури, однотипні за своєю природою. Тому феномени можна розглядати як самостійні предмети, здатні самоконструюватися.

Ціль структурно-феноменологічного аналізу виявлення структур, які є загальними як для свідомості так і для реальних предметів.

Салютогенез

(salus - лат. здоров'я, genesis - походження)

Термін введений соціологом Антоновським у 1979р., який означає підхід до оздоровлення через природні властивості людини в процесах саморегуляції.



Відповідно з визначеним системним підходом ми маємо три рівні терапевтично-відновлюваного впливу на травмовану людину:



1. Тілесно-орієнтована терапія

Через тіло - підсвідомий вплив на свідомість та мотивацію життя - методи фізичної реабілітації, апаратна фізіотерапія, кінезіотерапія, лікувальний масаж, остеопатія, ритмічні втирання лікувальних мазей та олій, сухі теплі грязеві компреси Юра-Фанго, масляно-десперсійні ванни...

(Активна-Пасивна)

Виконавці:

Лікар, фізичний терапевт, остеопат, реабілітолог.

Основні цілі:

Стабілізація фізичного стану, функціональної активності (больовий синдром, артеріальний тиск, проблеми травлення, порушення сну...) Набуття тілесної впевненості, усвідомлення свого функціонального стану, фізичних можливостей.



2. Терапія через вплив культурної діяльності

Через почуття - вплив на свідомість та мотивацію життя – творчो-мистецька діяльність, музика, кіно, живопис, тварини, танці, фізична культура та спорт (використовувати вправи зі скелелазіння, щоб відновити довіру до себе та інших, яку було втрачено через травму), працетерапія активна та пасивна, групова та індивідуальна робота.

Виконавці:

Психотерапевт, тренер, психолог, ерготерапевт, арттерапевт.

Основні цілі:

Набуття довіри в соціальному житті, стосунків між людьми, натхнення та спроможності в творчої діяльності



3. Терапія – свідомою практикою мислення ціннісної свідомості

Пряме усвідомлення сенсу, мотивації в житті. Групова та індивідуальна робота. Екзистенційні питання цінностей, життя та смерть, історія, наука, культура, релігія, біографія, родина, традиції тощо

Виконавці:

Командна робота : лікар, психолог, пастор, історик, філософ, діячі культури, юрист, ...

Основні цілі:

Набуття ціннісної свідомості, самодостатності, гідності, духовний розвиток, віра в себе, усвідомлення своєї біографії.

Структурні складові реабілітаційної допомоги :

**Безпечне місце як передумова стабілізації стану та
опрацювання травми.**

Для людей із травматичним життєвим досвідом світ став місцем загрози та невизначеності.

Травма похитує віру в себе та довіру до світу, залишає сліди страху, які перетворюють оточуюче середовище на місце потенційної небезпеки сприйняття внутрішнього відчуття безпеки порушується.

1. Стабілізація жертви – структурні компоненти реабілітаційної допомоги:

- Зовнішня стабілізація: зовнішнє оточуюче середовище - безпечне місце
- Фізична стабілізація: власне тіло як безпечне місце
- Соматично-регенеративна стабілізація: людські ритми як безпечне місце
- Внутрішня психологічна стабілізація: душа як безпечне місце
- Психосоціальна стабілізація: надійні стосунки як безпечне місце. Травма руйнує довіру.
- Ментальна стабілізація: «Я» людини як безпечне місце
- Духовна стабілізація: трансцендентальний світ як безпечне місце

2. Безпечне місце - фізичний, психосоціальний та духовний рівні в структурі реабілітаційної допомоги.

- Фізичний рівень: чітка структура приміщень мають ефект впливу більш на психо-емоційний стан людини. Чіткість, прозорість і естетика лікують!
- Психо-соціальний рівень: структура стосунків. Травмованим людям потрібні стабільні стосунки. Відносини лікують!
- Біографічний рівень: просторові, часові, стосункові, біографічні та мовні структури. Травматичний досвід має бути замінений досвідом самоефективності та здатності діяти. Мова теж може лікувати!

Notfall- und traumarpädagogische Methoden (Методи невідкладної педагогічної допомоги травм), Паціфаль-центр, Карслуе.



